Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)

À RETENIR

- CPVF infiltrant = profil **BRAF**, extension lymphatique (comme le CPT) ; encapsulé non invasif = **NIFTP** ; encapsulé invasif = profil **RAS**, dissémination sanguine.
- Carcinome vésiculaire : invasion minime, angio-invasif (préciser le nombre de vaisseaux : cut-off **4**), largement invasif.
- Oncocytaire : **> 75 %** de cellules oncocytaires, entité à part, **réfractaire à l'iode**.
- Trabéculaire ou solide : **> 50 %** des cellules.
- Sous-types agressifs : cellules hautes (**> 30 %**), cylindrique, clou de tapissier.
- Carcinome de haut grade : ≥ **3 mitoses / 2 mm²**, nécrose ; survie à 5 ans **50 %**.
- Changements de terminologie : variante → sous-type ; Hürthle → oncocytaire ; peu différencié → haut grade ; NIFTP « carcinome » → « tumeur ».

I. Carcinome papillaire variante folliculaire (CPVF)

- **Infiltrant** : BRAF – extension lymphatique (comme le CPT).
- **Non infiltrant = encapsulé** :
  - tumeur folliculaire non invasive avec caractéristiques nucléaires de CP = **NIFTP** ;
  - tumeur folliculaire invasive (EC ou EV) = **RAS** – dissémination sanguine ; « **entité à part** », plus proche du vésiculaire.

II. Carcinome vésiculaire (CV)

1. Avec invasion minime (EC = effraction capsulaire).
2. Angio-invasif (EV) → préciser le nombre de vaisseaux : cut-off **4**.
3. Largement invasif.

III. Carcinome oncocytaire

1. **> 75 %** de cellules oncocytaires (cellule ronde – noyaux volumineux ↑ – mitochondries).
2. Entité à part, sauf si anomalies nucléaires de CP → CP variante oncocytaire.
3. **Réfractaire à l'iode**.

IV. Trabéculaire ou solide

- **> 50 %** des cellules.

V. Sous-types agressifs

1. Cellules hautes **> 30 %**.
2. Cylindrique.
3. Clou de tapissier (« hobnail »).

VI. Carcinome de haut grade

1. Architecture : solide – trabéculaire – insulaire.
2. Pas d'anomalies nucléaires de CP.
3. ≥ **3 mitoses / 2 mm²**, nécrose.

Survie à 5 ans : **50 %**.

VII. Tumeurs de faible risque

1. NIFTP.
2. Tumeur trabéculaire hyalinisante.
3. Tumeurs à potentiel de malignité incertain.

VIII. Tableau des changements 2017 → 2022

OMS 2017 (4e éd.)	OMS 2022 (5e éd.)
Biologie moléculaire	Intérêt pronostique et thérapeutique
Mitoses / 10 champs	Mitoses / **2 mm²**
Variante	Sous-type
MCPT (microcarcinome papillaire)	< **1 cm** (pris en considération dans le TNM)
Cribriforme-morulaire	Potentiel de malignité incertain
Hürthle	Oncocytaire = oxyphile
Peu différencié	Haut grade
NIFTP : carcinome	Tumeur

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel profil moléculaire pour le CPVF infiltrant et pour le CPVF encapsulé invasif ?	Infiltrant : BRAF (extension lymphatique) ; encapsulé invasif : RAS (dissémination sanguine).
2. Que signifie NIFTP ?	Tumeur folliculaire non invasive avec caractéristiques nucléaires de CP.
3. Quel cut-off de vaisseaux envahis pour le CV angio-invasif ?	4.
4. Définition du carcinome oncocytaire ?	> 75 % de cellules oncocytaires ; réfractaire à l'iode.
5. Citez les 3 sous-types agressifs.	Cellules hautes (> 30 %), cylindrique, clou de tapissier.
6. Critères du carcinome de haut grade ?	Architecture solide/trabéculaire/insulaire, pas d'anomalies nucléaires de CP, ≥ 3 mitoses/2 mm², nécrose.
7. Nouveau nom du carcinome peu différencié et du Hürthle ?	Haut grade ; oncocytaire (oxyphile).